Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
Vara Estadual da Saúde Pública

Rua Manoelito de Ornelas, 50 - Bairro: Praia de Belas - CEP: 90110230 - Fone: (51) 3210-6500 - Email: frpoacentvesp@tjrs.jus.br

TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE Nº 5146560-84.2025.8.21.0001/RS

REQUERENTE: EDSON LUIS LOPES ABELLA

REQUERIDO: IPE-SAÚDE - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

EDSON LUIS LOPES ABELLA ajuizou ação ordinária em face do IPE-SAÚDE alegando possuir diagnóstico de **neoplasia maligna do cólon, não especificada (CID10-C18.9)**, **com metástase** e que, em razão disso, necessita fazer uso do medicamento **Trastuzumabe Deruxtecana 5,4mg/kg (480mg) EV**. Requereu a procedência da demanda, a fim de que seja fornecida a medicação postulada (evento 1, INIC1).

Indeferida a gratuidade da justiça (evento 15, DESPADEC1), a parte autora interpôs agravo de instrumento que foi julgado procedente (processo 5184137-51.2025.8.21.7000/TJRS, evento 23, RELVOTO1).

Deferida a tutela de urgência (evento 29, DESPADEC1).

O IPE-SAÚDE informou a autorização administrativa para o tratamento com o fármaco postulado (evento 42, OFIC1).

Citado, o réu contestou, alegando, em síntese, que não pode admitir, nem ser compelido à cobertura de um tratamento que excede o previsto por seu regulamento, de custo elevado, sob pena de ser levado à insolvência, prejudicando a coletividade associada. Requereu a improcedência da ação (evento 46, PET1).

A parte autora apresentou réplica (evento 54, RÉPLICA1).

Instadas as partes sobre eventual interesse na dilação probatória (evento 55, ATOORD1), nada requereram (evento 60, PET1; evento 64, PET1).

O Ministério Público opinou pela procedência da demanda (evento 70, PROMOÇÃO1).

É o relatório.

Passo a fundamentar.

I. DO MÉRITO

I.1. Do Direito à Saúde

Destaca-se, de início, que a Constituição Federal, em seu art. 5º, *caput*, ao tratar dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, garantiu o direito à vida e em seu art. 6º, *caput,* que cuida dos direitos sociais, assegurou o direito à saúde, dentre outros. Não bastasse isso, o art. 196, que trata da ordem social, prescreveu o direito à saúde de forma circunstanciada.

A Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, no mesmo sentido, em seu art. 241, preceitua que a saúde é um direito de todos.

I.2. Da necessidade do tratamento

No caso em análise, a tutela de urgência foi deferida, a qual abaixo colaciono e passo a ratificar (evento 29, DESPADEC1):

> *Segundo o laudo médico acostado aos autos, a parte autora apresenta o diagnóstico de neoplasia maligna do cólon, não especificada (CID10-C18.9), com metástase, necessitando fazer uso do medicamento Trastuzumabe Deruxtecana (Enhertu®) 5,4mg/kg (480mg) EV, a cada 3 semanas. Ressaltou a **urgência** do tratamento, sob **risco de progressão de doença, incapacidade de seguir o tratamento ou mesmo morte** (evento 12, ANEXO5):*
>
> *[...]*
>
> *A nota técnica, por sua vez, sobreveio com **conclusão favorável** ao tratamento requerido (evento 26, NOTATEC1):*
>
> *[...]*
>
> *Ademais, foi juntada ao feito a negativa administrativa do IPÊ-SAÚDE (evento 1, OUT3).*
>
> *Vale dizer, restando comprovado que a parte autora necessita submeter-se ao tratamento postulado, não há razão para a negativa do IPE-SAÚDE, a quem incumbe assegurar o tratamento e a intervenção mais adequados para o trato da sua enfermidade.*

Importante aduzir, ainda, que a parte autora mantém contrato firmado com o Instituto, contribuindo para o referido plano de saúde, o qual deve lhe garantir acesso amplo e seguro à assistência à saúde.

Por fim, ressalto que, embora este juízo não desconheça que a Lei Complementar nº 15.145/18 excluiu o fornecimento dos tratamentos não previstos nas tabelas do instituto (artigo 4º, §1º), é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que cabe ao plano de saúde prever as enfermidades as quais será fornecida a cobertura de tratamento, entretanto não é facultado ao plano escolher quais tratamentos serão dispensados. Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MATERIAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE TRATAMENTO A DOENÇA COBERTA. ÍNDOLE ABUSIVA. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, AINDA QUE IMPLÍCITO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento consolidado nesta Corte, é possível o reconhecimento de prequestionamento implícito, para fins de conhecimento do recurso especial, quando as questões debatidas no recurso especial tenham sido decididas no acórdão recorrido, ainda que sem a explícita indicação dos dispositivos de lei que o fundamentaram. In casu, a questão atinente ao valor atribuído na origem às astreintes não foi debatida nem decidida no acórdão de origem, não tendo sido prequestionado o art. 461, § 6º, do CPC/73. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. "A jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico" (AgInt no AREsp 949.765/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 1º/12/2016, DJe de 19/12/2016). 3. Agravo interno não provido.

Dessa forma, comprovados a probabilidade do direito e a urgência consistente no perigo de dano, tenho, em cognição sumária, que é caso de deferimento da tutela de urgência.

*Ante o exposto, **DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA** para determinar ao IPÊ-SAÚDE que, no prazo de 05 (cinco) dias, passe a disponibilizar à parte autora o medicamento **Trastuzumabe Deruxtecana (Enhertu®)**, nos termos da prescrição médica, pelo tempo necessário à realização do seu tratamento.*

A necessidade resta evidenciada pela documentação médica acostada aos autos (evento 12, ANEXO5), que indica possuir a parte autora diagnóstico de **neoplasia maligna do cólon, não especificada (CID10-C18.9)** e que, em razão disso, é imprescindível o uso do medicamento **Trastuzumabe Deruxtecana 5,4mg/kg (480mg) EV**. Da mesma forma, comprovada a urgência do tratamento, salientando o laudo médico que o uso mais breve possível da medicação evitará a progressão da doença, a incapacidade de seguir o tratamento e o risco de morte. Senão vejamos:

CREMERS
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

AUTARQUIA FEDERAL

Receituário Médico

PACIENTE
Edson Luis Lopes Abella
CPF: 254.310.560-34

*** RETIFICAÇÃO ***

LAUDO MÉDICO PARA JUSTIFICATIVA TERAPÊUTICA:
Justificativa para Uso de Trastuzumabe Deruxtecana (Enhertu®) em Paciente com Adenocarcinoma de Cólon Metastático HER2-Positivo Refratário a terapias anteriores.

Paciente: Edson Luis Lopes Abella
CPF: 254.310.560-34
Convênio: IPERGS
Médico Solicitante: Dr Vinícius Lorandi
Especialidade: Oncologia Clínica

1. Diagnóstico e Estadiamento:
O Sr Edson, 68 anos, foi diagnosticado com adenocarcinoma de cólon metastático (CID-10: C18.9), com sítios de metástase em fígado, pulmão e peritônio.
O diagnóstico foi confirmado por exame histopatológico de lesão do cólon transverso realizado em 17/08/2024.
A avaliação molecular do tumor revelou hiperexpressão/amplificação do gene HER2 (Receptor do Fator de Crescimento Epidérmico Humano 2), confirmada por Imuno-histoquímica (IHQ) com escore 3+, além da ausência de mutações nos genes RAS e BRAF.

2. Histórico de Tratamentos Anteriores e Resposta:
O paciente foi submetido a tratamentos sistêmicos prévios para doença metastática, que incluíram oxaliplatina e irinotecano associados a 5-fluorouracila.

Atualmente o paciente apresenta progressão de doença documentada por tomografia computadorizada realizada em maio/2025, evidenciando progressão hepática e abdominal. O status de performance do paciente é ECOG/Karnofsky 1.

3. Justificativa para a Terapêutica Proposta com Trastuzumabe Deruxtecana (Enhertu®):
Considerando a falha terapêutica às linhas de quimioterapia padrão (contendo oxaliplatina e irinotecano) para adenocarcinoma de cólon metastático e a documentada hiperexpressão/amplificação de HER2 no tumor do paciente, propus o tratamento com Trastuzumabe Deruxtecana (T-DXd, Enhertu®).

A hiperexpressão de HER2 ocorre em uma pequena porcentagem de pacientes com câncer colorretal metastático (aproximadamente 2-5%) e representa um biomarcador para terapia-alvo específica. Pacientes com tumores HER2-positivos que progridem após quimioterapia convencional têm opções terapêuticas limitadas e prognóstico reservado.

O Trastuzumabe Deruxtecana é um anticorpo-droga conjugado (ADC) direcionado ao HER2. Ele consiste em um anticorpo monoclonal anti-HER2 (trastuzumabe) ligado covalentemente a um inibidor de topoisomerase I (deruxtecana). Após a ligação ao HER2 na superfície da célula tumoral, o complexo é internalizado e a carga citotóxica é liberada, levando à morte celular. Além disso, o T-DXd demonstrou um efeito "bystander", no qual as células tumorais vizinhas, mesmo com baixa expressão de HER2, também podem ser afetadas pela carga citotóxica.

Estudos clínicos pivotais, como o DESTINY-CRC01 (publicado por Siena et al., Lancet Oncology 2021) e o DESTINY-CRC02, demonstraram atividade antitumoral significativa e

Este documento foi emitido e assinado digitalmente por Vinicius Lorandi 36342RS através do sistema ESPACO MEDICO do CREMERS em 09/06/2025 22:21:40

duradoura do Trastuzumabe Deruxtecana em pacientes com câncer colorretal metastático HER2-positivo, previamente tratados e refratários a terapias padrão. Nestes estudos, o T-DXd resultou em taxas de resposta objetiva clinicamente relevantes e sobrevida livre de progressão promissora nesta população de pacientes com poucas alternativas terapêuticas.

A literatura médica atual suporta o uso de Trastuzumabe Deruxtecana como uma opção terapêutica eficaz para pacientes com adenocarcinoma de cólon metastático HER2-positivo que falharam às terapias sistêmicas anteriores. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) aprovou o Enhertu® (Trastuzumabe Deruxtecana) para o tratamento de pacientes adultos com tumores sólidos HER2-positivos (IHC3+) irressecáveis ou metastáticos que receberam tratamento prévio ou que não possuem opções de tratamento alternativas satisfatórias. Para câncer de cólon HER2+, a indicação é baseada em dados de estudos robustos e recomendações de diretrizes internacionais (ex: NCCN, ESMO) como uma opção para pacientes que progrediram às terapias padrão.

4. Plano Terapêutico Proposto:
Medicamento: Trastuzumabe Deruxtecana (Enhertu®)
Dose: 5.4 mg/kg (Peso do paciente = 89kg --> dose total: 480mg)
Via de Administração: Intravenosa
Frequência: A cada 3 semanas
Duração do Tratamento: Até progressão de doença, toxicidade inaceitável ou decisão do paciente/médico. A pedido do paciente, reporto mediana de uso por volta de 5 meses, conforme estudo Destiny-CRC02.

O paciente será monitorado de perto e regularmente para avaliação de resposta terapêutica e manejo de potenciais efeitos adversos, que podem incluir, mas não se limitam a, náuseas, fadiga, alopecia, toxicidade hematológica e doença pulmonar intersticial (DPI).

5. Conclusão e Recomendação:
Com base no diagnóstico de adenocarcinoma de cólon metastático com hiperexpressão de HER2, refratariedade às linhas de quimioterapia padrão contendo oxaliplatina e irinotecano, e nas robustas evidências científicas que demonstram a eficácia e o benefício clínico do Trastuzumabe Deruxtecana nesta população específica, recomenda-se e justifica-se o tratamento com Trastuzumabe Deruxtecana (Enhertu®).

Acredita-se que esta terapia oferece a melhor oportunidade de controle da doença e potencial melhora na qualidade de vida para o paciente neste momento. Devido ao volume de doença e órgãos acometidos, o início da terapia tem urgência de ser iniciada, sob risco de progressão de doença, incapacidade de seguir o tratamento ou mesmo morte.

Coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Atenciosamente,

09 de Junho de 2025

Vinícius Lorandi CRM-RS 36342

Clínica Médica (RQE: 26469), Oncologia Clínica (RQE: 31942)

Endereço Comercial: R COSTA 30 / 4º ANDAR, MENINO DEUS, PORTO ALEGRE - RS

Telefone: (51) 3234-4332

ICP Brasil

Receituário emitido no dia 09/06/2025 22:21:40 por Vinícius Lorandi - 36342/RS para Edson Luis Lopes Abella (CPF: 254.310.560-34 jamileabella@gmail.com).

Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do CREMERS, na Internet, no endereço: **https://servicos.cremers.org.br/crvirtual-prescricao/#/validador/receita/f6hvRL4j** ou diretamente em um dispositivo móvel com leitor de QRCODE.

Com efeito, o(a) médico(a) assistente é quem detém a melhor capacidade para indicar os medicamentos com melhor eficácia para o tratamento da parte autora.

A assistência à saúde prestada pelo IPE-Saúde está submetida ao regime de direito público e deve seguir as regras definidas na Lei Complementar nº 15.145/2018 e os atos normativos da autarquia estadual, o que afasta a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto.

Em 06.04.2018, entrou em vigor a Lei Complementar nº 15.145/2018, que dispõe sobre a reestruturação do Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul – Sistema IPE-Saúde, revogando a Lei Complementar nº 12.134/2004 e excluindo da cobertura do IPE-Saúde os procedimentos, exames, tratamentos, insumos, materiais e medicamentos que não estejam previstos nas tabelas próprias do Instituto (art. 4º, § 1º).

Destarte, comprovado que a parte autora necessita submeter-se ao tratamento preconizado pelo(a) médico(a) assistente, não há razão para a negativa do IPE-Saúde, a quem incumbe assegurar o tratamento e a intervenção mais adequados para o trato da sua enfermidade. Para tanto, seria necessário que o Instituto requerido expusesse de forma clara e específica a justificativa técnica médica para o indeferimento do tratamento postulado.

Importante aduzir que a parte autora mantém contrato firmado com o Instituto, contribuindo para o referido plano de saúde, o qual deve lhe garantir acesso amplo e seguro à assistência à saúde.

Logo, considerando a gravidade da enfermidade que acomete a parte autora, não se mostra minimamente razoável limitar as alternativas terapêuticas disponíveis para o seu tratamento às listadas em protocolo que historicamente não consegue acompanhar a velocidade dos avanços da medicina, o que, caso ocorresse, configuraria efetiva negativa de adequado tratamento à parte autora, expondo-a a risco de dano irreparável a sua saúde.

Ademais, descabida a alegação do demandado de que o fornecimento da prestação de saúde, por não estar previsto nas suas tabelas vigentes à época, implicaria sobrecarga ou mesmo comprometimento do orçamento da autarquia destinado à saúde, porquanto eventual negativa, nessas circunstâncias, só poderia ocorrer com base em contestação técnica médica suficiente.

Não há prova alguma no processo que evidencie qualquer impedimento ao cumprimento da determinação judicial pelo demandado. Outrossim, a autarquia não se desincumbiu de provar que o tratamento indicado pelo médico assistente acarretaria oneração desnecessária para o Instituto.

Com efeito, em que pese a medicação solicitada não constasse nas tabelas de cobertura da autarquia, não há que se falar em ilegalidade da pretensão da parte autora, tampouco em afronta aos princípios da isonomia e da igualdade. Neste sentido:

> *APELAÇÃO CÍVEL. IPE-SAÚDE. PACIENTE COM DIAGNÓSTICO DE NEOPLASIA DE COLO UTERINO (CID 10 C53).* ***NEGATIVA DE COBERTURA ADMINISTRATIVA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CALCADA NA AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. EXEGESE DO ART. 4º DA LEI COMPLEMENTAR N.º 15.145/2018. SUFICIÊNCIA DO LAUDO MÉDICO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E ISONOMIA. INOCORRÊNCIA.*** *MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. 1. Conforme preconiza o artigo 4º*

da Lei Complementar n.º 15.145/2018, aplicável ao caso em análise, o Plano IPE-SAÚDE é integrado pelos atendimentos médicos, hospitalares, envolvendo os atos necessários ao diagnóstico e ao tratamento, bem como ações de prevenção da doença e à promoção da saúde. Inegável, assim, a responsabilidade de custeio integral do fármaco ora postulado. 2. ***A escolha do medicamento e do tipo de tratamento a ser concedido ao paciente cabe ao médico e não ao convênio, já que somente o profissional especializado é quem poderá optar e recomendar qual o melhor método e/ou material a ser utilizado em cada caso, tudo no objetivo de alcançar o melhor resultado.*** *3. Não merece guarida o apelo do IPE Saúde quanto à pretensão de redução da verba honorária sucumbencial. Com efeito, os honorários de sucumbência fixados em favor do patrono da parte autora observaram os parâmetros razoáveis, estando em conformidade com o disposto no art. 85, §§2º e 8º, do CPC/15. APELAÇÃO DESPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50004065020158210130, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 25-05-2022) [grifos nossos].*

Dessa maneira, evidenciado o direito ao fornecimento do(s) medicamento(s) postulado(s) ao tratamento de sua patologia, imperioso o julgamento procedente da ação.

Diante do exposto, **JULGO PROCEDENTES** os pedidos formulados por EDSON LUIS LOPES ABELLA em face do IPE-SAÚDE, tornando definitiva a decisão que deferiu a tutela de urgência, determinando o fornecimento do medicamento **Transtuzumabe Deruxtecana,** na dosagem e periodicidade determinadas pelo médico assistente, e por tempo indeterminado.

Isento o demandado do pagamento da **Taxa Única de Serviços Judiciais**, consoante o previsto no artigo 5º, inciso I, da Lei nº 14.634/14.

Condeno o demandado ao pagamento das **despesas processuais NÃO ABRANGIDAS PELA TAXA ÚNICA** (artigos 14 e seguintes da Lei nº 14.634/2014, e artigo 84 do CPC), bem como ao pagamento de **honorários sucumbenciais** ao(à) procurador(a) da parte autora, que fixo em R$ 2.000,00, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC.

Em conformidade ao artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, o valor dos honorários deverá ser atualizado monetariamente pela Taxa Selic a contar da data da sua fixação; com incidência de juros moratórios, segundo o mesmo índice da Taxa Selic, a contar do trânsito em julgado, conforme artigo 85, §16, do CPC.

Sentença registrada e publicada eletronicamente, da qual vão as partes intimadas via sistema Eproc.

Interposta apelação, processe-se, conforme os trâmites legais e, após, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça.

Havendo saldo vinculado ao feito, expeça-se alvará a quem de direito.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e procedam-se com os **atos ordinários necessários** à cobrança de eventuais despesas processuais: expedição de RPV, intimações, alvarás para destinação dos valores e demais atos.

Consigno que, após o trânsito em julgado da sentença, nos termos do Ofício-Circular nº 077/2019-CGJ, o cumprimento de sentença deverá tramitar com novo número de processo no Eproc, incumbindo ao exequente distribuí-lo em autos apartados, vinculando o número do processo de conhecimento e recolhendo as custas correspondentes, se for o caso.

Por fim, baixe-se.

Documento assinado eletronicamente por **LETICIA MICHELON, Juíza de Direito**, em 09/09/2025, às 14:56:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10090564711v6** e o código CRC **bbb393a6**.